БОНУС 3

Шаблони за представяне на случай на визитация

Структура на представяне за 60 и 120 секунди, 8 шаблона според типа случай, готови изречения, които ще Ви бъдат полезни на визитация, и 6 примерни представяния от началото до края.

Съдържание

Как да използвате тези шаблони

Глава 1 · Представяне за 60 секунди

Глава 2 · Представяне за 120 секунди

Глава 3 · 8 шаблона според типа случай

Глава 4 · Изречения, които помагат на визитация

Глава 5 · 6 примерни представяния

Глава 6 · Последна проверка преди представянето

Следваща стъпка

КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как да използвате тези шаблони

Доброто представяне на случай е изговорената версия на доброто описание: същият ред, същата яснота.

> *На визитация най-често Ви затруднява не липсата на знания, а изгубването на реда. Шаблонът пази реда вместо Вас; Вие се фокусирате върху находката.*

Представянето следва **метода от 4 стъпки** – същия, който използвате при писане на описание:

СТЪПКА	СЪОТВЕТСТВИЕ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
1 · ПОДГОТВЕТЕ	Пациент (възраст, пол), клиничен въпрос, изследване и протокол, техническа адекватност.
2 · ПРЕГЛЕДАЙТЕ	Изречението «Оцених систематично»; посочете накратко кои области сте прегледали.
3 · ОПИШЕТЕ	Основна находка: правилен термин, локализация, размер, контури; сравнение с предишното изследване. След това съпътстващите находки.
4 · ОБОБЩЕТЕ	Заключение в едно изречение, диференциална диагноза, препоръка; на кого и кога е съобщена спешната находка.

Три златни правила

1. **Не оставяйте заключението за края.** Дори при представяне за 60 секунди кажете клиничния въпрос в първото изречение и ясното заключение в последното.
2. **Говорете, докато показвате образа.** Докато описвате находката, дръжте този срез отворен на екрана и посочете към него.
3. **Не измисляйте това, което не знаете.** Да кажете «Не съм сигурен/сигурна в това, бих искал/а да го оценя заедно с моя ръководител» е проява на професионализъм.

> **Практика**
>
> Първо изпробвайте всеки шаблон три пъти на глас, със засичане на времето. Запишете времето си в Тетрадката за упражнения; целта е да завършите представянето за 60 секунди за по-малко от 60 секунди.

ГЛАВА 1

Представяне за 60 секунди

Предаване на дежурството, визитация в коридора, когато Ви кажат «накратко».

ВРЕМЕ	КАКВО КАЗВАТЕ
0–10 сек · Идентификация и въпрос	«[Възраст]-годишен/годишна [мъж/жена]; поради [оплакване/клиничен въпрос] е направена [изследване].»
10–15 сек · Техника	«Изследването е с диагностично качество.» или «Оценката е ограничена поради [ограничение].»
15–40 сек · Основна находка	«В [локализация] се вижда [находка] с [размер], [контури], [плътност/сигнал/ехогенност]. Спрямо предишното изследване [промяна].»
40–50 сек · Съпътстващи находки	«Съпътстваща [находка] има / няма. Не се вижда [важна отрицателна находка].»
50–60 сек · Заключение	«В заключение съответства на [диагноза]; в диференциалната диагноза [1–2 диагнози]. [Препоръка]. [Съобщено на клиничния екип].»

Тайната на краткостта

За 60 секунди кажете само една основна находка и най-много две важни отрицателни находки. Останалото разгърнете, ако Ви попитат.

ГЛАВА 2

Представяне за 120 секунди

Сутрешна визитация, клинично обсъждане на случаи, моментът, в който Вашият ръководител каже «разкажете отначало».

ВРЕМЕ	КАКВО КАЗВАТЕ
0–15 сек · Идентификация и клиника	Възраст, пол, оплакване и продължителност, релевантна анамнеза, клиничен въпрос.
15–25 сек · Изследване и техника	Модалност, контраст и фаза (или секвенции), техническа адекватност, наличие на предишни изследвания.
25–35 сек · Преглед	«Оцених систематично [областите].»
35–75 сек · Основна находка	Пълно описание с правилния термин: локализация, размер (в две или три равнини), контури, вътрешна структура, контрастно усилване; сравнение.
75–90 сек · Съпътстващи и отрицателни находки	Усложнения, съпътстващи находки, важни отрицателни находки, свързани с клиничния въпрос.
90–110 сек · Заключение и диференциална диагноза	Заключение в едно изречение; защо в диференциалната диагноза мислите първо за това.
110–120 сек · Препоръка и комуникация	Препоръка за допълнително изследване или проследяване; при спешна находка – на кого и кога е съобщена.

Честа грешка

При представянето за 120 секунди най-много време се губи в изречението за прегледа. Не изброявайте нормалните органи един по един: достатъчно е да кажете «Останалите паренхимни органи са без особености»; важните отрицателни находки, свързани с клиничния въпрос, обаче споменете отделно.

ГЛАВА 3

8 шаблона според типа случай

Попълнете празните места, не променяйте реда.

ШАБЛОН 1

Спешна находка (напр. кръвоизлив, пневмоторакс, свободен газ)

1. «Започвам със спешна находка: [находка].»
2. Пациент, клиничен въпрос, изследване.
3. Локализация, размер и ефект на находката (напр. обемен ефект, изместване, колапс).
4. Усложнения и съпътстващи находки.
5. «В [час] е информиран [клиничният екип/лекарят].»

ШАБЛОН 2

Нормално изследване

1. Пациент, клиничен въпрос, изследване и техническа адекватност.
2. «При систематичната оценка не установих патологична находка.»
3. Важни отрицателни находки, свързани с клиничния въпрос (напр. «не се виждат кръвоизлив, обемен ефект и фрактура»).
4. Ако изследването има ограничения, посочете ги (напр. ранната исхемия може да не се вижда на нативна КТ).
5. При нужда – препоръка.

ШАБЛОН 3

Маса / лезия

1. Пациент, клиничен въпрос, изследване и контрастни фази.
2. Локализация, размер, контури, вътрешна структура и контрастно поведение на лезията.
3. Връзка със съседните структури, белези на инвазия.
4. Лимфни възли и далечни находки.
5. Диференциална диагноза (започвайки от най-вероятната) и препоръка за допълнително изследване.

ШАБЛОН 4

Инфекция / възпаление

1. Пациент, клиника (температура, болка, лабораторни данни, ако има), изследване.
2. Основна възпалителна находка: локализация, разпространение.
3. Усложнение: абсцес, перфорация, обструкция, разпространение.
4. Диференциална диагноза.
5. Препоръка (има ли колекция, подходяща за дрениране, нужно ли е проследяване).

ШАБЛОН 5

Травма

1. Пациент, механизъм на травмата, изследване.
2. Първо най-тежкото увреждане (находката, застрашаваща живота).
3. Останалите увреждания в систематичен ред (отгоре надолу или орган по орган).
4. Важни отрицателни находки (напр. «не се вижда активна екстравазация на контраст»).
5. Съобщаване и препоръка.

ШАБЛОН 6

Контролно изследване (сравнително)

1. Пациент, известна диагноза, дата и модалност на предишното изследване.
2. Днешният размер на известната лезия и промяната спрямо предишния (измерено по същия метод).
3. Има ли новопоявила се находка.
4. Обща оценка: регресия, стабилно състояние, прогресия.
5. Препоръка.

ШАБЛОН 7

Проверка на тръба / катетър / устройство

1. Пациент, изследване, проверявано(и) устройство(а).
2. Къде е върхът на всяко устройство; в очакваната позиция ли е.
3. Усложнение, свързано с устройството (пневмоторакс, малпозиция, прегъване).
4. Промяна спрямо предишната рентгенография.
5. Съобщаване, ако позицията не е правилна.

ШАБЛОН 8

Случайна находка

1. Първо клиничният въпрос и отговорът на него.
2. «Освен това случайно се вижда [находка].»
3. Описание на находката.
4. Препоръка според клиничното значение и подхода за проследяване, който използва Вашето отделение.
5. Имало ли я е на предишните изследвания.

ГЛАВА 4

Изречения, които помагат на визитация

Правилното изречение носи правилната степен на увереност.

СИТУАЦИЯ	ИЗРЕЧЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
Начало	«[Възраст]-годишен/годишна [мъж/жена]; поради [клиничен въпрос] е направена [изследване].»
Техническо ограничение	«Оценката на [област] е ограничена поради двигателни артефакти.»
Сравнение	«В сравнение с [изследване] от [дата] [находка] [се е увеличила/намаляла/не се е променила] по [размер/вид].»
Няма предишно изследване	«Няма предишно изследване за сравнение.»
Висока увереност	«Съответства на ....»
Средна увереност	«В полза на ...; в диференциалната диагноза може да се обсъди ....»
Ниска увереност	«... не може да се изключи.»
Важна отрицателна находка	«По отношение на клиничния въпрос не се вижда ....»
Препоръка	«По отношение на ... може да се препоръча оценка с [изследване].»
Съобщаване	«Находката е съобщена в [час] на [съответния лекар].»
Въпрос, на който не знаете отговора	«Не съм сигурен/сигурна по този въпрос; ще прочета и ще Ви отговоря на утрешната визитация.»
Ако Вашият ръководител мисли различно	«Аз мислех за ... поради ...; бих искал/а да разбера как оценявате Вие находката ....»
Когато времето не стига	«Накратко: съответства на ..., съобщено на .... Искате ли да покажа подробностите?»
Край	«В заключение ...; препоръката ми е ....»

Изрази, които да избягвате

- «Май има нещо» — назовете находката и нейната локализация.
- «Изглежда нормално» — или е нормално, или посочете ограничението.
- «Лек», «изразен» (без размер) — дайте размер.
- «Тумор» (когато няма тъканна диагноза) — казвайте «маса» или «обемна лезия».

- «Плътност» при ЯМР, «засенчване» при ехография — използвайте термина на съответната модалност.

ГЛАВА 5

6 примерни представяния

Всички случаи са измислени; подготвени са само за да покажат структурата на представянето.

ПРИМЕР 1 · 60 СЕКУНДИ · ШАБЛОН 1

КТ на мозък след травма

«Започвам със спешна находка: **остър субдурален хематом**.

Седемдесет и две годишен мъж; след падане вкъщи и нарушено съзнание е направена нативна КТ на мозък. Изследването е с диагностично качество.

По хода на левия фронтопариетален конвекситет, успоредно на вътрешната ламина на черепа, се вижда сърповидна хиперденсна екстрааксиална колекция. Има компресия на лявата странична камера и изместване на средната линия надясно.

В костен прозорец не установих фрактура. Не се вижда съпътстващ паренхимен кръвоизлив.

В заключение находките съответстват на остър субдурален хематом с обемен ефект. Находката е съобщена в 03:10 ч. на лекаря от спешното отделение.»

ПРИМЕР 2 · 60 СЕКУНДИ · ШАБЛОН 7

Рентгенография на гръден кош в интензивно отделение

«Шестдесет и пет годишна жена; след интубация е направена леглова АР рентгенография на гръден кош за контрол на тръбата. Има лека ротация, достатъчна за оценка.

Върхът на ендотрахеалната тръба е непосредствено над нивото на карината – по-дистално от позицията, която очаква нашето отделение. Върхът на десния югуларен централен венозен катетър е на нивото на горната празна вена. Назогастралната сонда достига под диафрагмата.

Не се вижда пневмоторакс. Спрямо предишната рентгенография няма нова консолидация.

В заключение върхът на ендотрахеалната тръба е разположен дистално; препоръчва се преценка за изтеглянето ѝ. Съобщено на лекаря от интензивното отделение.»

ПРИМЕР 3 · 120 СЕКУНДИ · ШАБЛОН 4

Болка в десния долен квадрант, КТ на корем

«Двайсет и осем годишен мъж, постъпва с болка в десния долен квадрант от два дни и температура; клиничен въпрос – остър апендицит. Направена е КТ на корем и малък таз с контраст в портовенозна фаза; няма предишно изследване. Изследването е с диагностично качество.

Оцених корема систематично: свободен газ, паренхимни органи, черва, съдове и малък таз.

Апендиксът е с увеличен диаметър, със задебелена и контрастно усилваща се стена. В лумена има хиперденсно огнище, съответстващо на апендиколит. В периапендикуларната мастна тъкан се вижда инфилтрация и малко количество свободна течност.

Не установих колекция, съответстваща на абсцес, нито свободен газ. Стената на терминалния илеум и цекума е без особености. Десният бъбрек и ходът на уретера са без особености, не се вижда конкремент.

В заключение **неусложнен остър апендицит** – находките съответстват на тази диагноза. В диференциалната диагноза могат да се обсъдят цекален дивертикулит и терминален илеит, но находките са центрирани в апендикса.

Находката е съобщена на специализанта по обща хирургия.»

ПРИМЕР 4 · 120 СЕКУНДИ · ШАБЛОН 3

Белодробна маса на КТ на гръден кош

«Шестдесет и осем годишен мъж, постъпва с дългогодишно тютюнопушене в анамнезата и кашлица от три месеца; поради засенчване на рентгенографията на гръден кош е направена КТ на гръден кош с контраст. За сравнение е налична само рентгенография на гръден кош отпреди един месец.

Направих систематична оценка в белодробен и медиастинален прозорец.

В горния лоб на десния бял дроб се вижда солидна маса с неправилни и спикулирани контури и хетерогенно контрастно усилване. Масата съответства на засенчването на рентгенографията. Има съмнение за разпространение към плеврата; инвазия в гръдната стена не е налице.

В десния хилус и долната паратрахеална област има увеличени лимфни възли. В левия бял дроб не установих нодул. Попадащите в среза надбъбречни жлези и черен дроб са без особености; в костите не се виждат литични лезии.

В заключение **в полза на първичен белодробен малигнитет** са масата и хилусно-медиастиналната лимфаденопатия. За тъканна диагноза и стадиране се препоръчва допълнително изследване.

Бих искал/а да финализирам описанието заедно с моя ръководител.»

ПРИМЕР 5 · 60 СЕКУНДИ · ШАБЛОН 2

Главоболие, нормална КТ на мозък

«Четирийсетгодишна жена; поради главоболие от една седмица е направена нативна КТ на мозък. Изследването е с диагностично качество.

При систематичната оценка не установих патологична находка.

Не се виждат кръвоизлив, обемен ефект и изместване на средната линия. Вентрикулите и цистерните са без особености. Диференциацията между сиво и бяло вещество е запазена. В костен прозорец няма патология; синусите са въздушни.

Знаем, че нативната КТ има ограничения при показването на някои патологии; ако клиничното съмнение продължава, допълнително изследване може да се обсъди заедно с клиничния екип.»

ПРИМЕР 6 · 120 СЕКУНДИ · ШАБЛОН 6

Проследяване на лезия на черния дроб

«Петдесет и пет годишна жена, оперирана по повод малигнитет на дебелото черво; за проследяване на известна единична лезия в черния дроб е направена КТ на корем с контраст в портовенозна фаза. Сравних с КТ отпреди шест месеца. Изследването е с диагностично качество.

Оцених корема систематично.

Известната хиподенсна лезия в десния чернодробен лоб е регресирала по размер, измерена по същия метод и на същия срез като при предишното изследване. Контурите и вътрешната структура на лезията не са се променили съществено.

Не установих нова лезия в черния дроб. Не се виждат находки, съответстващи на лимфаденопатия, асцит или перитонеални импланти. В зоната на анастомозата няма видима патология. В попадащите в среза белодробни бази не се виждат нодули.

В заключение при известната лезия на черния дроб се установява **регресия по размер**; няма нова лезия. Спрямо предишното изследване може да се оцени като отговор на лечението.

Интервалът на проследяване може да се определи според плана на клиничния екип.»

ГЛАВА 6

Последна проверка преди представянето

Отделете 2 минути преди визитацията.

Преди всяко представяне

- [ ] Мога да кажа възрастта, пола и клиничния въпрос на пациента в едно изречение.
- [ ] Бележката ми за изследването, контрастната фаза или секвенциите и техническата адекватност е готова.
- [ ] Отворих предишното изследване и сравних (или отбелязах, че липсва).
- [ ] Срезът, който показва основната находка, е готов на екрана.
- [ ] За основната находка използвам правилния термин (плътност / сигнал / ехогенност).
- [ ] Имам поне две важни отрицателни находки, свързани с клиничния въпрос.
- [ ] Заключението ми в едно изречение и диференциалната диагноза са готови.
- [ ] Ако има спешна находка, знам на кого и кога е съобщена.
- [ ] Направих една безмълвна репетиция на представянето със засичане на времето.

Златно правило

Единственото, което ще остане в паметта на Вашия ръководител от визитацията, е последното Ви изречение. Напишете заключението си предварително и го кажете дума по дума.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Сега изберете един случай от 100-те практически случая и с подходящия от Шаблони 1–8 направете представяне за 60 секунди, като засичате времето.

За да упражните предварително въпросите, които могат да Ви зададат при представянето, преминете към **300 въпроса за визитация и устен изпит**.